2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

O diálogo como princípio orientador da Educação Popular em Saúde na Atenção Primária: Percepção de profissionais da Rocinha (RJ)

Clara Beatriz Teixeira Lima Cavalcante [1], Vanessa de Almeida Ferreira Corrêa [2]

1 – Programa de Residência em Enfermagem de Família e Comunidade (PREFC)
2 – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

PRINCIPAIS ACHADOS DO SEU TRABALHO

O diálogo, segundo os participantes do estudo, está presente no cotidiano das práticas assistenciais como ferramenta fundamental para a construção de um cuidado humanizado, compartilhado e centrado no usuário. Através da escuta qualificada, valorização da subjetividade, do contexto de vida e dos saberes populares, é possível a elaboração conjunta de planos de cuidado individualizados e contextualizados, sendo uma potente ferramenta de descolonização do saber científico.

Introdução

A Educação Popular em Saúde (EPS) constitui-se como uma abordagem teórico-metodológica e ético-política fundamentada na construção coletiva do saber, no diálogo, na escuta e na emancipação dos sujeitos. Instituída como política pública, a EPS propõe a reorientação das práticas tradicionais de cuidado, destacando o diálogo como princípio orientador, especialmente no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS).

Objetivos

Objetiva-se descrever a percepção do diálogo como princípio orientador de práticas fundamentadas na EPS, sob a ótica de profissionais da APS no município do Rio de Janeiro (RJ).

Métodos

Trata-se de uma pesquisa descritiva, qualitativa, com 22 profissionais atuantes em Clínicas da Família do bairro da Rocinha, no município do Rio de Janeiro, Brasil. Dentre os participantes, compuseram a amostra da pesquisa: Médicos, Enfermeiros, Agentes Comunitários de Saúde, Técnicos de Enfermagem, Dentistas e profissionais em processo de especialização, como residentes de enfermagem e medicina.

Resultados

O diálogo é compreendido como elemento vital para a construção de práticas de cuidado humanizadas, participativas e contextualizadas, expresso pelos participantes através da valorização dos saberes populares, da subjetividade, das vivências e do contexto de vida dos usuários.

As falas indicam a síntese entre os saberes da comunidade e o conhecimento científico, contribuindo para a construção de projetos terapêuticos individualizados, compartilhados e alinhados à realidade local, bem como a descolonização das práticas de cuidado, por vezes, ainda ancoradas no modelo biomédico.

Destacam-se ainda os espaços coletivos e territoriais como potentes dispositivos para trocas dialógicas e fortalecimento do cuidado compartilhado, extrapolando o espaço do consultório.

"Na minha rotina de assistência [...] trocamos diálogo e experiências em como são nossos hábitos diários de alimentação, exercícios e etc. E com essa comunicação podemos trocar ideias sobre pequenos detalhes que podem fazer a diferença com relação ao cuidado" A1

"Nos atendimentos, sempre dialogo com os usuários para entender o que eles sabem sobre sua doença/ condição e quais saberes eles têm quanto a terapêuticas para que juntos possamos construir um plano de manejo conjunto, que é individual para cada pessoa e que deve respeitar e entender cada indivíduo" RM1

"Um exemplo são as trocas que ocorrem na consulta sobre mudanças no estilo de vida ou nas orientações de higiene do sono, onde conversamos sobre o uso de chás de ervas, diminuição do uso de telas, e os usuários logo associam a tradições familiares sobre" RE5

"Ao dialogar com o usuário sob sua condição de saúde e perceber o que ele carrega como bagagem de vida e conhecimento e o que pode realizar para contribuir na melhora de sua qualidade de vida" E7

Conclusão/Considerações finais

Conclui-se que o diálogo, enquanto princípio da EPS, fortalece a integralidade, a participação social e a reorientação das práticas de cuidado na APS, de modo a facilitar construção de estratégias terapêuticas mais sensíveis, efetivas e socialmente contextualizadas.

INSTITUIÇÃO
Clara Beatriz Teixeira Lima Cavalcante

Programa de Residência em Enfermagem de Família e Comunidade (PREFC).

E-mail: clarabia21@gmail.com
Contatos: (21) 97158-1659